



物质使用障碍

(成瘾；物质滥用)

作者：[Mashal Khan](#), MD, NewYork-Presbyterian Hospital
Reviewed By [Mark Zimmerman](#), MD, South County Psychiatry
已审核/已修订 8月 2025 | 修改的 9月 2025

物质使用障碍通常涉及人们持续使用某种物质（例如，非法药物）的行为模式，尽管使用该物质已造成问题。

涉及的物质往往是通常导致物质相关障碍的 10 类药物的成员。

表格
与物质相关障碍相关的十类常见药物
饮酒
抗焦虑及镇静药
咖啡因
大麻 （包括 大麻 和 合成大麻素 ）
致幻剂 （包括麦角酸二乙基酰胺 [LSD]、苯环利定、裸头草碱、3,4-亚甲二氧基甲基苯丙胺 [MDMA]）
吸入剂 （如油漆稀释剂和某些胶水）
阿片类药物 （包括芬太尼、吗啡和羟考酮）
娱乐性药物（包括 安非他命 和 可卡因 ）
吸烟
其他（包括 合成代谢类固醇 和其他常见滥用物质）

中毒和戒断的具体表现和治疗因物质或物质分类而异。

与“成瘾”、“滥用”或“依赖”相比，“物质使用障碍”一词更准确，定义更清晰，负面含义更少。

使用非法药物，尽管从法律角度来说有问题，但并不总是涉及到物质使用障碍。另一方面，合法物质（如酒精和处方药；美国境内允许使用大麻的州越来越多）*可能*涉及物质使用障碍。在所有社会经济群体中，都存在使用处方药和非法药物导致的问题。

几百年来药物的娱乐性使用一直以各种形式存在。人们出于各种原因用药，包括以下：

- 改变或增强某种情绪
- 作为宗教仪式的一部分
- 获得精神感悟
- 提高自身表现

出于娱乐目的服药的人可能偶尔会在相对小的剂量下服用，通常不会对自己造成伤害。也就是说，使用者不会产生药物戒断，并且该药物不会对身体造成损害（至少在短期内不会）。通常认为娱乐性药物包括鸦片、酒精、尼古丁、大麻、咖啡因、迷幻蘑菇（另请参见蘑菇[毒蕈]中毒）、可卡因。许多娱乐性药物被认为是“自然的”，因为它们近似于其植物来源。它们含有低浓度精神活性成分的混合物，而非分离出来的更高浓度精神活性化合物。

娱乐性药物可口服、吸入或注射使用。

物质使用的生理作用

这些物质都直接激活大脑的奖励系统并产生愉悦感。激活可能非常强烈，以致人们强烈渴望使用该物质。他们可能会忽视正常的活动来获取和使用该药物。这些物质也具有直接生理影响，包括

- 中毒
- 戒断
- 物质诱发的心理健康疾病

中毒

中毒指特定药物产生的快速而暂时的作用。中毒损害了人的心理功能和判断力，并可能改变情绪。根据药物性质，患者可能会感到兴奋或夸张的幸福（或欣快感），或可能感觉比平常更平静，更放松和睡意更强。

许多药物影响身体功能和协调性，导致摔倒、撞车。有的药物触发攻击性行为，造成打架。随着药物应用剂量加大，副作用会表现得更为明显（称为超剂量），会产生并发症，有时有死亡的危险。

耐受指人们需服用越来越多的该药物才能达到原先较小剂量所产生的效果。人们对阿片类药及酒精可产生巨大耐受性。

戒断

戒断是指患者停止使用某种物质或者用量明显低于平时时出现的症状。戒断会导致各种不愉快的症状，这取决于所涉及的物质。有些药物（像酒精及巴比妥）的戒断症状可能非常严重甚至危及生命。大多数体验过戒断的人都知道，使用更多的物质会减轻他们的症状。

是否发生戒断，仅取决于所使用物质和使用多长时间，而不是该人是否有**物质使用障碍**、是否是娱乐性地使用该物质，或者该物质是否非法的。某些处方药特别是阿片类，镇静剂和兴奋剂，即使按照合法医疗原因以及相对较短的时间（阿片类药物少于 1 周）服用，也可能导致戒断症状。

有戒断症状的人以前被称为对该物质躯体依赖。然而，“依赖”含有暗示非法药物使用的负面含义，因此医生倾向于避免使用这种术语。

物质使用障碍的原因

人们通常从试探使用，发展到偶尔使用，然后大量使用，有时还会发生物质使用障碍。这种进展很复杂，目前我们只能理解其中的某些部分。该过程取决于药物、使用者和环境之间的相互作用。

药物

10 类药物中的各种药物，其导致物质使用障碍的可能性各不相同。滥用这些药物的可能性取决于多种因素，包括以下因素：

- 怎样使用药物
- 药物刺激大脑奖赏途径的力度有多大
- 药物起效有多快
- 该药产生**耐受**和/或**戒断症状**的能力

此外，合法和/或容易获得的物质，如**酒精**和**烟草**，更可能首先被使用。随着人们继续使用一种物质，他们通常认为使用它的风险较小，并且可能开始增加其使用和/或试着用其他物质。人们对风险的看法也可能受到用药的社会和法律后果的影响。

在治疗疾病或手术或牙科手术过程中，人们常规使用阿片类药物。如果患者没有服用所开具的全部药量，那么药物有时会落在希望以娱乐目的使用它们的人的手中。由于将这些药物用于非医疗目的已经成为如此大的问题，许多医疗保健提供者已经做出了下列回应

- 建议酌情使用或处方非成瘾性止痛药物（如对乙酰氨基酚、非甾体类消炎药
- 处方较少量的阿片类药物
- 鼓励人们安全地存储或处置任何剩余的药物
- 扩大处方回收计划

使用者

可能发物质使用障碍的使用者因素包括

- 心理特征
- 环境和（精神）障碍

心理特征不是一个非常明显的重要因素，但自我控制水平低的人（冲动性）或高水平的冒险和寻求新奇的行为可能会增加物质使用障碍的风险。但是，罕有科学证据支持部分行为学家描述的“成瘾性格”概念。

许多**环境因素和并存疾病**，似乎增加了物质使用障碍的风险。例如：

- 悲伤、情绪低落、被社会疏远或情感依恋缺乏安全感的人可能会从使用物质中找到暂时的解脱，这可能会导致更多的使用，有时还会导致物质使用障碍。
- 患有**焦虑症**、**抑郁症**、**精神分裂症**、**注意力缺陷障碍**和**人格障碍**等其他无关精神疾病的人，患物质使用障碍的风险也会增加。（同时患有精神障碍和物质使用障碍的人被称为“双重诊断”。）
- **慢性疼痛**患者通常需要**阿片类药物**缓解症状。其中一些人后来发展成物质使用障碍。

然而，在许多此类患者中，**非阿片类药物**和其他治疗不足以缓解疼痛和痛苦。

物质使用障碍可能有许多原因，其中一些是遗传原因，其他则是表观遗传原因（行为的影响和基因环境）。对特定基因异常的研究因特定物质而异。研究人员发现，在有和没有物质使用障碍的人之间，生化或代谢差异很小。

地点

文化和社会因素对于物质使用的开始和维持（或复发）非常重要。看到家庭成员（如父母、较年长的兄弟姐妹）和同龄人使用物质，会增加人们开始使用物质的风险。同伴在青少年中尤其具有强大的影响力（参见**青少年中的物质使用**）。试图停止使用某种物质的人会发现，如果身边有同样使用该物质的其他人，这会更加困难。

医生如果过分热情地通过开药来帮助患者缓解压力，可能会无意间导致有害地使用精神药物。包括大众媒体在内的许多社会因素，都会助长用药物来缓解所有痛苦的期望。

物质使用障碍的诊断

- 医师的评估
- 有时进行血液、尿液或毛发检查

有时，人们因希望停用某种药物而求助于医务人员，此时可对物质使用障碍作出诊断。另一些人则试图掩盖使用物质的事实，或者没有意识到这是一个问题。医生、家人、朋友或同事只有在注意到一个人的情绪或行为发生变化时，才会怀疑他有物质使用障碍。有时医生会在体格检查或血常规检查期间发现物质使用的迹象。比如说，他们可能会发现频繁静脉注射药物在注射部位留下的痕迹。这些痕迹是一些在一片黑色的或变了色的皮肤周围的细小的线、黑色小点（针头注射所致）。皮下注射毒品会产生环状皮肤伤痕或溃疡。患者会声称是其他的原因造成的皮肤上的痕迹，他们或解释为是频繁献血，或虫咬伤，或是其他原因造成的损伤。或者，他们可能会发现一些体征或血液检测结果，显示过量饮酒对肝脏造成了损害。有些人会因使用过量药物（药物过量）或因使用（中毒）或停止使用药物（戒断）而导致严重不适，需要紧急护理。

医务人员也使用其他方法（比如调查问卷）来识别物质使用障碍。可以做尿液检测，有些情况下也可以做血液或毛发检测来检测现用药物情况。

诊断标准

物质使用障碍的诊断采用标准的精神病诊断标准，可分为4类。在12个月内，满足2个或更多这些标准的人，被认为有物质使用障碍。

- 患者无法控制对物质的使用。
- 患者履行社会义务的能力因使用该物质而受到损害。
- 患者在身体危险的情况下使用该物质。
- 患者显示使用和/或依赖的体征。

无法控制使用

- 患者以比原计划更大量或更长的时间使用该物质。
- 患者希望停止或减少该物质的使用。
- 患者花费大量时间获得、使用或从物质的影响中恢复过来。
- 患者渴望该物质。

社会功能障碍

- 患者未能履行在工作、学校或家中的主要角色义务。
- 即使它导致社会或人际问题或使之恶化，患者仍继续使用该物质。
- 由于物质使用，患者放弃或减少重要的社会、职业或娱乐活动。

危险的使用

- 患者在躯体危险的情况下使用该物质（例如，驾驶时或处于危险的社会环境中）。
- 尽管知道它正在导致医疗或心理问题恶化，患者仍在继续使用该物质。

躯体症状

- **耐受**：患者需要越来越多地使用该物质才能感受到所需的效果。
- **戒断**：当物质停止或被另一种物质抵消时，会出现不愉快的躯体效应。

应注意，某些处方药特别是阿片类、镇静/催眠药和兴奋剂，即使按照合法医疗原因以及相对较短的时间（阿片类药物少于 1 周）服用，也可能导致耐受和/或戒断症状。在适当的医疗用途下出现的戒断症状不能确诊物质使用障碍。例如，当晚期癌症引起严重疼痛的患者变得依赖于阿片类药物（如吗啡），其戒断症状并不被视为物质使用障碍的证据。

物质使用障碍的严重程度由满足条目的数量决定：

- 轻度：2 至 3 条标准
- 中度：4 至 5 条标准
- 重度：≥ 6 条标准

物质使用障碍的治疗

- 随所用物质不同，具体情况不同而定

具体的治疗方法依赖于使用了何种药物，但一般情况下这是靠询问而得之，有时还需要知道其它药物使用情况。家人支持及支持团体可以帮助毒品滥用者停止毒品使用。

物质使用障碍已广泛存在，导致的死亡人数也在增加。为应对这种日益增长的流行病，许多组织制定了伤害减轻计划，以提供教育、咨询和转诊治疗。他们的目的是减少药物使用者继续服药带来的害处。有些提供全国电话帮助热线。

因为共用针头是[人类免疫缺陷病毒 \(HIV\) 感染](#)、[肝炎](#)及其他感染的常见原因，所以一些伤害减轻计划提供干净的针头和注射器，使人们不会重复使用其他人的针头。这项措施有助减少这些感染的传播（也减少了社会资金的消耗）。

筛查

物质使用障碍的常规筛查应纳入定期健康维护就诊中，而不是仅在医生怀疑时才进行。以筛查为基础的方法可以让医生及早发现物质使用障碍并进行有效干预，而不会让人们蒙受耻辱或促使他们在障碍恶化时隐瞒物质使用情况。

在有效的常规筛查中，医生会询问患者使用的常见物质类别，包括酒精、烟草/尼古丁、大麻、处方药和非法药物。医生可能会使用正式的评估工具，也可能只问一个问题（例如，“在过去一年中，你有多少次非医疗原因使用非法药物或使用处方药？”）

如果筛查问题引起了对物质使用障碍或与物质使用相关的其他问题的担忧，医生将确定物质使用障碍的严重程度、对患者工作能力的影响以及患者可能存在的任何相关心理健康问题。在适当的时候，医生会将病人转介到专门的医疗机构。

预防

有些物质使用障碍是可以通过早期识别和管理风险因素来预防的。常规筛查和与年龄相适应的保护策略是医生可以采用的重要措施，尤其是在青春期，因为此时最有可能开始使用物质，而且人的神经生物学易受成瘾影响的程度也更高。

在对已知的风险因素进行评估后，包括物质使用障碍的家族史、患者遭受的创伤、是否存在其他心理健康问题以及早期行为问题，医生会考虑采取预防性干预措施，如心理教育、认知和行为技能培养以及基于家庭的支持。

还应教育患者和家属有关用药过量的风险，尤其是在处方阿片类药物时，如果有用药过量的高风险或物质使用障碍，则应给予或处方纳洛酮（如鼻内纳洛酮/Narcan）。